

정신·감정·영적 생활방식 인자 패널

Dr. Jennifer Jackson · Dr. David Haase

▶ 공동 우선순위 설정 & 소통

- 환자는 두 부류: ① 즉시 변화 준비 ② "발가락만 담가보기" → 둘 다 ok, 환자가 있는 곳에서 만나라
- 공동 우선순위는 진료 첫 순간부터 시작: 눈 맞춤·약수·이름 부르기·따뜻한 분위기
- 환자는 말보다 느낌으로 더 많이 받아들인다 → 의사 자신의 마음가짐이 핵심
- 환자 이야기 되돌려 말해주기 = 그 자체로 치유 / 어떤 검사보다 중요한 정보
- 환자가 스스로 아이디어를 내고 결정해야만 실제 변화가 일어난다

▶ 수면을 시작점으로 — 생활방식 인자 연결 전략

- 수면은 저항감이 가장 적다 → 시작하기 좋은 출발점
- 수면에서 변화를 못 만들면 나머지가 작동하지 않는다
- 수면 + 야외 아침 산책(광생물조절) + 걷기(운동) + 심호흡(스트레스) + 긍정적 관계 회상(관계) → 한 번에 5가지 인자 통합
- 마찰 많은 인자들로 들어가는 부드러운 진입로로 수면을 활용
- 웨어러블 기기: 수면 질 평가에 유용

▶ 강점 중심 접근법

- "What's wrong with you?" → "What's strong with you?" (Dr. Jackson의 핵심 전환)
- 문제 목록(problem list) + 강점 목록(strengths list) 동시에 유지
- 첫 만남의 목표: 보장된 성공(guaranteed success) — 작은 승리 하나가 다음 발걸음을 만든다
- 첫 실패 → 자책 → 변화 포기의 악순환을 막는 것이 핵심

▶ 정신·감정·영적 영역 접근법

- 환자가 먼저 꺼내는 이야기 = 안전한 진입 신호 → 더 깊이 물어볼 수 있다
- "저는 정신·감정·영적 문제를 편하게 이야기합니다"라고 먼저 씨앗 심기
- "나는 스위스다(중립)" — 판단 없는 안전한 공간 선언
- 환자가 주도하게 하면 더 나은 곳에 도달한다
- 영적 경험을 꺼내는 환자 → 목격자(witness)가 되어주는 것으로 충분

▶ 바로 쓸 수 있는 임상 도구

- 자기에 질문: "당신은 자신을 사랑하나요? 당신을 사랑하는 사람들의 눈으로 보면 어떻게 살 것 같나요?"
- 심박변이도(HRV): 장-뇌 축, 자율신경계 조절의 바이오마커
- 호흡 조절(paced breathing): 지금 이 순간 신체 감각 변화 체험 → 자기효능감의 첫 경험

- "큰 이유(big why)" 탐색: 표면적 목표 너머 진정한 가치 찾기 → 영적 영역과 연결
- "시간" 질문: "하루 중 자신을 위한 시간을 어떻게 보내나요?" → 독립적이어서 거부감 낮음